

L'incontinence urinaire d'effort (IUE) est une fuite d'urine lors d'une pression soudaine sur la vessie — tousser, éternuer, rire, soulever ou faire de l'exercice. Chez la femme, cela survient lorsque le soutien sous l'urètre s'affaiblit, souvent après un accouchement ou la ménopause. C'est très fréquent et très traitable, des exercices simples jusqu'à une chirurgie rapide et très efficace.

À propos de cette affection

L'**urètre** (le tube par lequel l'urine s'écoule) reste normalement fermé lors d'une toux ou d'un effort, grâce au soutien du plancher pelvien et des tissus environnants. Lorsque ce soutien s'affaiblit, une hausse soudaine de la pression abdominale fait fuir l'urine. Le signe caractéristique est la **fuite à l'effort** — non pas avec une envie soudaine (c'est la vessie hyperactive ; avoir les deux s'appelle une incontinence **mixte**).

Causes

- **Grossesse et accouchement** (cause principale)
- **Ménopause** et vieillissement
- Toux chronique, constipation ou port de charges lourdes
- Surpoids et antécédents de chirurgie pelvienne

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence d'effort

Fuite urinaire sous l'effet d'une pression — toux, effort, exercice.

Urètre

Le tube qui évacue l'urine hors du corps.

Plancher pelvien

Les muscles qui soutiennent la vessie et l'urètre.

Exercices de Kegel

Contractions du plancher pelvien pour renforcer le soutien.

Incontinence mixte

Fuites à l'effort et fuites par urgenturie.

Pessaire / dispositif intravaginal

Un petit support placé dans le vagin pour réduire les fuites.

Injection d'agent comblant

Une injection en cabinet qui aide l'urètre à se fermer.

Bandelette sous-urétrale

Un petit soutien en maillage placé sous l'urètre lors d'une chirurgie.

AI-JE BESOIN D'UNE CHIRURGIE ? Pas nécessairement. Beaucoup de femmes s'améliorent avec les exercices du plancher pelvien et de simples changements ; certaines utilisent un dispositif de soutien. La chirurgie (telle qu'une bandelette) est très efficace si vous souhaitez un résultat durable — mais c'est votre choix, et vous pouvez commencer par les étapes les plus simples.

Comment on le diagnostique

- Un entretien sur le moment des fuites et un examen (parfois un test de toux)
- Un **test d'urine** pour écarter une infection, et une vérification de la vidange vésicale
- Parfois un bilan urodynamique avant une chirurgie

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **Exercices du plancher pelvien** (Kegel) et kinésithérapie, perte de poids, traitement de la toux ou de la constipation.
- 2 **Dispositifs de soutien** — un pessaire ou un dispositif intravaginal en vente libre.
- 3 **Injection d'agent comblant** — une injection rapide en cabinet qui aide l'urètre à se fermer.
- 4 **Chirurgie** — une **bandelette sous-urétrale** (ou une bandelette autologue) pour une réparation durable. Chaque option dispose de sa propre fiche d'information.

Vivre avec l'IUE

- Apprenez à **contracter avant de tousser, d'éternuer ou de soulever** (la « technique de protection »).
- Faites les exercices du plancher pelvien quotidiennement — les résultats peuvent prendre 6 à 12 semaines.
- Traitez la constipation et la toux chronique, qui augmentent la pression.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Des brûlures, une urgenturie ou du **sang dans les urines** (infection possible)
- Des fuites accompagnées d'une **envie pressante** — le traitement peut être différent
- La sensation que la vessie ne se vide pas complètement

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'IUE féminine est une fuite liée à la pression, due à un soutien affaibli sous l'urètre — fréquente et très traitable.
2. Les options vont des exercices du plancher pelvien et du pessaire à l'injection en cabinet, jusqu'à une bandelette pour un résultat durable.
3. Les exercices prennent des semaines à agir ; contractez avant de tousser ou de soulever. La chirurgie est un choix, pas une obligation.